



Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente
Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis
Coordenação-Geral de Vigilância do HIV/AIDS

NOTA TÉCNICA Nº 74/2026-CGHA/.DATHI/SVSA/MS

Assunto: Qualificação do processo de solicitação e realização do exame de genotipagem do HIV-1 no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O Ministério da Saúde, por intermédio da Coordenação-Geral de Vigilância do HIV/Aids do Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (CGHA/Dathi/SVSA/MS), mantém vigilância contínua sobre a execução dos processos concernentes ao cuidado integral das pessoas vivendo com HIV e/ou aids (PVHA), com o objetivo de identificar fragilidades assistenciais e promover aprimoramentos na linha de cuidado.

No âmbito dessa estratégia, foi elaborado plano de ação para qualificação do processo de solicitação, coleta, encaminhamento e realização do exame de genotipagem do HIV-1 no SUS, que contempla:

- Atualização dos critérios vigentes para solicitação do exame;
- Atualização do formulário de solicitação do exame, com exclusão de campos não essenciais e reorganização segundo categorias de indicação, tornando o preenchimento mais ágil;
- Recomendação da atuação de enfermeiros(as) e farmacêuticos(as) como solicitantes de exame de genotipagem do HIV-1 para a categoria Pré-tratamento;
- Desenvolvimento de estratégias de qualificação da rede técnica envolvida na solicitação do exame, coleta e envio de amostras para realização da genotipagem;
- Execução do exame de genotipagem do HIV-1 por meio de contratação de serviço centralizado.

Nesse contexto, a presente Nota Técnica apresenta as diretrizes e orientações relacionadas ao aprimoramento do processo de solicitação e realização do exame de genotipagem do HIV-1 no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), detalhando as ações priorizadas no plano de ação e os aspectos técnico-operacionais necessários à sua implementação.

2. CATEGORIAS DE SOLICITAÇÃO DO EXAME DE GENOTIPAGEM DO HIV-1

Os critérios para solicitação do exame de genotipagem do HIV-1 foram organizados em três categorias:

- **Categoria A:** Pré-tratamento
- **Categoria B:** Falha virológica confirmada
- **Categoria C:** Falha virológica suspeita

2.1. Pré-tratamento - Categoria A

A genotipagem pré-tratamento tem como objetivo a identificação de resistência primária ou transmitida, considerando análise de custo-efetividade baseada na prevalência dessas resistências na população.

Contempla **PVHA sem histórico prévio ou atual de uso da terapia antirretroviral (Tarv)**, sendo subdivida em duas subcategorias (**A1 e A2**), conforme **Quadro 1**, que descreve, ainda, os critérios para solicitação do exame de genotipagem do HIV-1 nessas populações.

Quadro 1 – Critérios para solicitações de exames de genotipagem do HIV-1 por categoria de solicitação.

Genotipagem pré-tratamento	
Categoria A	Critérios de solicitação do exame
Subcategoria A1 - Grupo prioritário	
Gestantes ^a	• PVHA sem histórico prévio ou atual de uso de Tarv; • A solicitação da genotipagem pré-tratamento somente deve ser realizada após a conclusão diagnóstica da infecção por HIV seguindo um dos algoritmos diagnósticos previstos no Manual Técnico para Diagnóstico da Infecção pelo HIV em adultos e crianças; • Para esta subcategoria, não será necessário possuir resultado de carga viral (CV-HIV) conhecido no momento da solicitação do exame; • Caso o resultado de CV-HIV esteja disponível, é opcional informá-lo na solicitação.
RN/Criança (<13 anos) ^{a,b,c}	
Adolescente (13-17 anos) ^{a,c}	
Subcategoria A2 - Outros Grupos	
Usuário de PrEP ^a	• Usuários sem histórico prévio ou atual de uso de Tarv; • Obrigatório ter realizado um exame de CV-HIV e ter o resultado ≥ 500 cópias/mL, o qual deve ser informado na solicitação do exame de genotipagem; • Intervalo entre a última CV-HIV e a solicitação do exame de genotipagem não deve ser maior que 12 meses.
Parceria sorodiferente ^{a,d}	
Coinfecção TB-HIV ^a	

- ^a Recomenda-se fortemente o preenchimento do “**Campo 14.1. Deglute comprimido**” para avaliação da melhor indicação de esquema terapêutico após resultado do exame de genotipagem do HIV-1.
- ^b Recomenda-se que seja informado o esquema profilático/preemptivo do recém-nascido/criança e esquema de TARV da mãe, para subsidiar a recomendação da melhor indicação de esquema terapêutico após resultado do exame de genotipagem do HIV-1.
- ^c Obrigatório o preenchimento do “**Campo 14. Peso**” para avaliação da melhor indicação de esquema terapêutico.
- ^d Recomenda-se fortemente que seja informado o esquema da parceria, quando disponível, para subsidiar a recomendação da melhor indicação de esquema terapêutico após resultado do exame de genotipagem do HIV-1.

Após a conclusão diagnóstica da infecção por HIV-1 nessas populações, a coleta de amostra para genotipagem pré-tratamento deve ser priorizada e realizada, preferencialmente, antes do início da TARV. Ressalta-se, entretanto, que o início do tratamento não deve ser postergado em caso de impossibilidade de coleta da amostra. Ressalta-se, ainda, que não é necessário aguardar o resultado da genotipagem para o início da TARV. O tratamento deve ser instituído prontamente e, caso necessário, o esquema terapêutico poderá ser ajustado após a liberação do laudo.

2.2. Falha virológica – categorias B e C

A genotipagem do HIV-1 em indivíduos com falha virológica visa detectar resistência adquirida durante o uso de Tarv.

A falha virológica é definida pela presença de **dois resultados de exames consecutivos de carga viral do HIV (CV-HIV) com valores iguais ou superiores a 200 cópias/mL**, realizados com intervalo mínimo de quatro semanas entre si, após pelo menos seis meses de uso contínuo da Tarv. Destaca-se que, quando há interrupção da Tarv, determinadas mutações podem tornar-se rapidamente arquivadas, deixando de ser detectáveis no sangue. Assim, é imprescindível que a amostra para genotipagem dessas categorias seja coletada **na vigência da Tarv há pelo menos 4 semanas**, assegurando obter uma amostra em que o vírus esteja sob a pressão seletiva exercida pelos antirretrovirais e maior probabilidade de detecção de mutações de resistência a esses fármacos.

A genotipagem no contexto de falha virológica foi subdividida em duas categorias: **Categoria B** – Falha virológica confirmada e **Categoria C** – Falha virológica suspeita, conforme **Quadro 2**, que contempla, ainda, os critérios para solicitação do exame de genotipagem do HIV-1 nessas populações. A subdivisão tem por objetivo diferenciar situações em que a confirmação da falha virológica é necessária daquelas que demandam maior celeridade no manejo clínico. Nesse contexto, a categoria C - **Falha virológica suspeita** destina-se exclusivamente à PVHA que, já em acompanhamento por infecção pelo HIV e em uso de terapia antirretroviral (Tarv), torne-se gestante, não sendo exigida a confirmação da falha virológica para solicitação da genotipagem. Essa excepcionalidade visa oportunizar, em tempo hábil, a avaliação de resistência viral e a adequação terapêutica, considerando a condição gestacional e a proteção do binômio gestante-feto. Diferencia-se, portanto, da **Categoria A – Pré-tratamento**, destinada à gestante recém-diagnosticada com HIV, sem exposição prévia à Tarv.

Quadro 2 – Critérios para solicitações de exames de genotipagem do HIV-1 por categoria de solicitação.

Genotipagem em falha virológica	
Categoria	Critérios de solicitação do exame
Categoria B – Falha Virológica Confirmada ^a	• Início de Tarv há pelo menos 6 meses ou após reintrodução de Tarv. • Ter falha virológica confirmada (dois resultados consecutivos de CV-HIV $\geq$ 200 cópias/mL) na vigência de uso de Tarv com intervalo mínimo de 4 semanas entre as coletas; sendo obrigatório ter o último resultado de CV-HIV $\geq$ 500 cópias/mL, devido à limitação da sensibilidade do exame de genotipagem do HIV-1^b; • Intervalo entre a última CV-HIV e a solicitação do exame de genotipagem não deve ser maior que 12 meses.
Categoria C – Falha Virológica Suspeita ^a	• Obrigatório ser PVHA que tenha se tornado gestante; • Uso prévio, reintrodução ou uso atual de Tarv. • Obrigatório ter resultado de CV-HIV $\geq$ 500 cópias/mL durante a gestação;

^a Falha virológica confirmada: dois resultados consecutivos de CV-HIV $\geq$ 200 cópias/mL, com intervalo mínimo de 4 semanas entre as coletas (e máximo de 12 meses), sendo a última superior a 500 cópias/mL.

^b Caso excepcionais poderão ser reportados para tratamento@ids.gov.br e diagnostico@ids.gov.br para avaliação.

3. CLASSES DE ANTIRRETROVIRAIS AVALIADAS NO EXAME DE GENOTIPAGEM DO HIV-1

A partir da análise de regiões específicas do genoma viral do HIV-1, o exame de genotipagem possibilita detectar alterações nos principais alvos terapêuticos utilizados na terapia antirretroviral, subsidiando a escolha ou a otimização do esquema terapêutico em casos de falha virológica. No contexto do SUS, a genotipagem pode contemplar a análise de diferentes genes virais, incluindo aqueles relacionados às enzimas transcriptase reversa, protease e integrase, bem como regiões associadas ao tropismo viral, conforme a indicação clínica e o histórico de uso de antirretrovirais. O **Quadro 3** apresenta os principais alvos terapêuticos avaliados no exame de genotipagem do HIV-1, as respectivas classes de antirretrovirais analisadas e quando serão avaliados em cada categoria de solicitação do exame:

Quadro 3 – Classes de antirretrovirais avaliadas em cada alvo e categoria de solicitação de genotipagem

Alvo	Classes analisadas	Categorias
Convencional	• ITRN • ITRNN • IP	Este alvo será avaliado em todas as categorias (A, B e C)
Integrase	• INI	Este alvo será avaliado para todos os usuários pertencentes à categoria A. Para as categorias B e C, o alvo será avaliado apenas para usuários com histórico atual ou prévio de uso de INI (Dolutegravir, Raltegravir e/ou Dolutegravir sódico)

Genotropismo (alça V3 GP120)	Inibidor de entrada	Este alvo será avaliado nas categorias B ou C, se o usuário já possuir histórico de uso atual ou prévio de Maraviroque em seu esquema de Tarv ou quando o laboratório executor identificar resistência a três ou quatro classes (ITRN, ITRNN, INI e IP) na amostra avaliada para todas as categorias (A, B ou C).
-------------------------------------	---	---

Legenda: ITRN (Inibidores da Transcriptase Reversa Análogos de Nucleosídeos); ITRNN (Inibidores da Transcriptase Reversa Não Análogos de Nucleosídeos); INI (Inibidores de Protease);

4. TEMPO MÍNIMO PARA SOLICITAÇÕES ENTRE EXAMES DE GENOTIPAGEM DO HIV-1

O intervalo mínimo para solicitação de novo exame de genotipagem do HIV-1 deverá ser de 60 dias, contados a partir da data de coleta de um exame anterior. Excepcionalmente, poderá ser realizada nova solicitação em intervalo inferior a 60 dias quando o resultado do exame anterior apresentar resultados “Indeterminado” e/ou “Não Amplificado” para um ou mais alvos. Nesses casos, uma nova amostra deverá ser coletada e o exame de genotipagem do HIV-1 deverá ser realizado com foco específico para o(s) alvo(s) previamente classificado(s) como “Indeterminado” e/ou “Não Amplificado”. Desta forma, o “Campo 24. Genotipagem Anterior Mais Recente” do formulário de solicitação do exame é de preenchimento obrigatório.

5. ATUALIZAÇÃO DO FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE EXAME DE GENOTIPAGEM DO HIV-1

Com o objetivo de assegurar a aplicação dos novos critérios para a solicitação do exame de genotipagem do HIV-1, o Formulário para Solicitação de Exame de Genotipagem do HIV-1 foi atualizado e está disponível para download e impressão pelo serviço de saúde, através do link: <http://www.gov.br/aids/pt-br/sistemas-de-informacao/sisgeno>, bem como, dentro do sistema LAUDO <http://laudo.aids.gov.br>. Este formulário deverá ser preenchido pelo profissional solicitante do exame e encaminhado impresso junto com a amostra coletada.

Orienta-se que os serviços da rede de saúde realizem a transição para utilização da versão mais recente do formulário de solicitação do exame de genotipagem do HIV-1. Nesse sentido, a partir da publicação da presente Nota Técnica, os serviços de saúde **terão um prazo de até três meses** para adequação dos fluxos internos e adoção do formulário e critérios atualizados. Após o término desse prazo, as amostras recebidas com formulários desatualizados estarão sujeitas à não conformidade documental e poderão não ser processadas pelo laboratório executor, por não atenderem aos critérios estabelecidos.

É indispensável que os formulários de solicitação, manuais ou digitados, apresentem todos os campos obrigatórios preenchidos integralmente. Essa medida assegura que a solicitação atenda aos critérios técnicos, prevenindo o descarte prematuro de amostras. Reforça-se que, conforme a normativa vigente, o CPF é o identificador oficial dos usuários do SUS nos sistemas do Ministério da Saúde. O preenchimento correto desse campo é crucial para garantir a rastreabilidade e a segurança do usuário, evitando homônimos ou erros de identificação que retardem e/ou comprometam o processo. Nos casos excepcionais (estrangeiros, indígenas, recém-nascidos até 5 anos, pessoas em situação de rua ou privadas de liberdade), a ausência do CPF exige a indicação explícita da justificativa correspondente no formulário para viabilizar o processamento laboratorial. A ausência dessa informação poderá impedir a correta identificação do usuário e o cadastro da solicitação pelo laboratório executor, podendo demandar contato com o serviço solicitante e, consequentemente, ocasionar atrasos na execução e liberação dos resultados.

6. SOLICITAÇÃO DE EXAME DE GENOTIPAGEM DO HIV-1 POR ENFERMEIROS(AS) E FARMACÊUTICOS(AS) PARA A CATEGORIA PRÉ-TRATAMENTO

Considerando que enfermeiros(as) e farmacêuticos(as) que atuam no cuidado à PVHA, no âmbito do SUS, integram diretamente o acompanhamento clínico e o monitoramento da adesão ao tratamento, recomenda-se a atuação de tais profissionais como **solicitantes de exames de genotipagem para a categoria A - Pré-tratamento**. Tal medida visa favorecer maior agilidade na identificação de possíveis casos de resistência transmitida e na definição da estratégia terapêutica mais adequada para o início da Tarv. Além disso, a ampliação dessa atribuição fortalece o cuidado multiprofissional e qualifica o fluxo assistencial, reduzindo o tempo entre a indicação e a solicitação da genotipagem, contribuindo para intervenções mais rápidas e adequadas, favorecendo a efetividade da terapia antirretroviral, o alcance da supressão viral e a melhoria dos desfechos clínicos das PVHA.

A presente recomendação observa as atribuições dos profissionais de enfermagem e farmácia no âmbito do SUS, respeitando a legislação profissional vigente, os protocolos clínicos e os fluxos assistenciais locais.

7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE GENOTIPAGEM DO HIV-1

O DATHI/SVSA/MS informa que, após a conclusão do Pregão Eletrônico nº 90121/2025, a empresa GERMSURE BIOSAFE E CONSULTORIA LTDA., sediada em Maricá/RJ, foi declarada vencedora do certame e passará a prestar o serviço de genotipagem do HIV-1.

Desta forma, todos os pedidos de recolhimento de amostras para o exame de genotipagem **até 17 de junho de 2026** serão ainda processados pelo Laboratório de AIDS e Imunologia Molecular (LABAIDS) do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). Os pedidos de recolhimento de amostras para o exame de genotipagem após o dia 17 de junho de 2026 passarão a ser responsabilidade do laboratório da empresa GERMSURE. A empresa contratada será responsável pelo recolhimento das amostras nos pontos indicados pelas Coordenações Estaduais de HIV/Aids e que podem ser consultados [clikando aqui](#).

A GERMSURE fornecerá os tubos destinados à coleta das amostras, os quais deverão ser utilizados exclusivamente para a realização do exame de genotipagem do HIV-1, além dos materiais necessários para o acondicionamento e transporte das amostras.

As orientações referentes à coleta, ao armazenamento e ao envio das amostras, bem como ao plano logístico para recolhimento, estão descritas no Anexo A da presente nota.

Durante o período de transição, eventuais dúvidas relacionadas à logística de coleta, acondicionamento, transporte ou processamento das amostras deverão ser encaminhadas aos canais oficiais divulgados pelo DATHI/SVSA/MS e pela empresa contratada.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reorganização dos critérios e do formulário de solicitação do exame de genotipagem do HIV-1 integra estratégia institucional de qualificação da assistência, racionalização de recursos e fortalecimento da vigilância da resistência aos antirretrovirais no Brasil.

A adequada observância dos critérios ora estabelecidos contribuirá para melhor gestão dos recursos do SUS, maior efetividade terapêutica, otimização do uso da TARV e qualificação do cuidado integral às pessoas vivendo com HIV e/ou aids.

Por fim, solicita-se o apoio das Coordenações Municipais e Estaduais de Saúde de HIV/Aids e dos Laboratórios de Saúde Pública na divulgação das atualizações relacionadas ao exame de genotipagem do HIV-1 previstas neste documento.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde, 2025. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) Oral à Infecção pelo HIV. Brasília: Ministério da Saúde,

2025. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-profilaxia-pre-exposicao-prep-oral-a-infeccao-pelo-hiv.pdf/@@display-file/file>.

BRASIL, Ministério da Saúde, 2024. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos: Módulo 1: Tratamento / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. – Brasília: Ministério da Saúde, 2024. 116 p.: il.

BRASIL, Ministério da Saúde, 2019. Manual Técnico para Avaliação de Exames de Genotipagem do HIV / Ministério da Saúde, Secretaria De Vigilância Em Saúde, Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 2019. Disponível em <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/2019/manual-tecnico-para-avaliacao-de-exames-de-genotipagem-do-hiv>

BRASIL. Ministério da Saúde, 2018. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. Manual técnico para o diagnóstico da infecção pelo HIV em adultos e crianças. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/2018/manual_tecnico_hiv_27_11_2018_web.pdf/@@display-file/file.

BRASIL. Ministério da Saúde. NOTA TÉCNICA Nº 142/2025-CGHA/.DATHI/SVSA/MS. Orienta o manejo para PVHA que estejam em uso de terapia dupla (TD) e apresentem carga viral detectável e abaixo de 500 cópias/ml. Brasília, DF, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/notas-tecnicas/2025/nota_tecnica_no-142_2025-cgha_dathisvs_ms.pdf/view

BRASIL. Ministério da Saúde. NOTA TÉCNICA Nº 283/2023-CGAHV/.DATHI/SVSA/MS. Dispõe sobre orientações para profissionais de saúde com relação à abordagem das pessoas vivendo com HIV/aids e carga viral detectável após mudança do fornecedor do teste de carga viral do HIV (CV-HIV). Brasília, DF, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/notas-tecnicas/2023/nota-tecnica-no-283-2023-cv-detectavel-apos-mudanca-do-fornecedor-profissionais-de-saude.pdf/view>



Documento assinado eletronicamente por **Artur Olhovetchi Kalichman, Coordenador(a)-Geral de Vigilância do HIV/AIDS**, em 12/06/2026, às 08:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Draurio Barreira Cravo Neto, Diretor(a) do Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis**, em 12/06/2026, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0055991119** e o código CRC **1B85E283**.

ANEXO A

FLUXO DE COLETA, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA GENOTIPAGEM DO HIV-1

ORIENTAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DO SUS



1. UNIDADE SOLICITANTE / COLETORA DE AMOSTRAS

1

COLETA DA AMOSTRA



- Coletar 2 (dois) tubos de sangue total com anticoagulante EDTA K2 de 4 mL (tubos de tampa roxa), SEM GEL SEPARADOR.
- Cada tubo deve ter volume mínimo de 3 mL.
- Identificar os tubos com o nome completo do usuário SUS e a data de nascimento, de forma legível.



AS AMOSTRAS NÃO DEVERÃO SER CENTRIFUGADAS.

2

FORNECIMENTO DOS TUBOS



- Os tubos de coleta serão fornecidos a unidade solicitante/coletora pelo ponto de recolhimento estabelecido pela Coordenação Estadual local.
- Solicitar a quantidade de tubos necessária, baseada na demanda da unidade, ao ponto de recolhimento mais próximo.

3

IMPORTANTE

Os tubos de coletas serão solicitados e entregues **APENAS** aos pontos de recolhimento de amostras indicados previamente.

3

ARMAZENAMENTO NA UNIDADE



- Manter as amostras sob temperatura de 2 a 8 °C (podem ser acondicionadas em geladeira).
- Não congelar as amostras.

4

ENVIO AO PONTO DE RECOLHIMENTO



- As amostras devem ser transportadas em suporte estável, evitando que as amostras virem.
- O transporte das amostras até o ponto de recolhimento mais próximo é de responsabilidade de cada unidade, através das pactuações locais e estaduais, e deve ser realizado em temperatura de até 8 °C. Recomenda-se utilização de gelo reciclável.

5

IMPORTANTE

A solicitação de envio das amostras deverá ser realizada **APENAS** pelos pontos de recolhimento de amostras.

- [Clique aqui](#) para consultar o ponto de recolhimento mais próximo de seu serviço de saúde.



Aponte a câmera para consultar os pontos de recolhimento de amostras



2. PONTO DE RECOLHIMENTO DE AMOSTRAS (LOCAIS ONDE O LABORATÓRIO EXECUTOR RETIRARÁ AS AMOSTRAS)

5

RECEBIMENTO DAS AMOSTRAS



- Conferir as amostras e a documentação recebida.
- Manter as amostras sob temperatura de 2 a 8 °C (podem ser acondicionadas em geladeira).
- Não congelar as amostras.

6

SOLICITAÇÃO DE TUBOS



- O ponto de recolhimento deve solicitar os tubos de coleta ao laboratório executor contratado através do e-mail: sac@germsure.com.br, enviando:
 - Nome da instituição solicitante;
 - Endereço completo para entrega;
 - Nome e contato do responsável pelo recebimento;
 - Quantidade e tipo de material solicitado.



IMPORTANTE

Os tubos de coletas serão solicitados e entregues **APENAS** aos pontos de recolhimento de amostras indicados previamente.

7

SOLICITAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE AMOSTRAS



- Realizar a solicitação de retirada das amostras ao laboratório executor contratado através do e-mail: sac@germsure.com.br, enviando:
 - Nome da instituição solicitante;
 - Município e UF do ponto de recolhimento;
 - Endereço completo para recolhimento;
 - Nome e telefone do responsável local pelas solicitação e entrega das amostras;
 - Quantidade de amostras a serem recolhidas;
 - Data e horário preferencial para retirada.



IMPORTANTE

A solicitação de envio das amostras deverá ser realizada **APENAS** pelos pontos de recolhimento de amostras.

8

ARMAZENAMENTO ATÉ RETIRADA



- Manter as amostras sob temperatura de 2 a 8 °C.
- Garantir que o envio ao laboratório executor ocorra dentro do prazo de 72 horas após a coleta.

9

ENTREGA DAS AMOSTRAS À TRANSPORTADORA



- Entregar as amostras e a documentação transportadora no momento da retirada.

DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR AS AMOSTRAS:

- ✓ Amostras para genotipagem do HIV-1 acondicionadas em suporte estável, evitando que as amostras virem;
- ✓ Formulário de Solicitação de Exame de Genotipagem do HIV-1 preenchido e assinado pelo(a) profissional solicitante;
- ✓ A caixa de transporte fornecida pelo laboratório executor, devidamente identificada com o nome e o endereço completo do ponto de recolhimento de amostras;
- ✓ Os formulários devem ser enviados dentro da caixa de transporte, em sacos plásticos, evitando umidade;
- ✓ Declaração de Transporte preenchida (será compartilhada pelo laboratório executor contratado por e-mail no momento da solicitação de recolhimento das amostras).



3. LABORATÓRIO EXECUTOR (CONTRATADO)

10

TRANSPORTE DAS AMOSTRAS



- O recolhimento das amostras nos pontos de recolhimento é de responsabilidade do laboratório executor contratado e com transportadora específica.
- As amostras serão transportadas em temperatura de 2 a 8 °C até o laboratório executor contratado.
- É de responsabilidade do laboratório executor contratado o fornecimento de todos os materiais envolvidos na logística de transporte de amostras (caixas de transporte, gelo reciclável e demais insumos necessários).

11

CRITÉRIOS DE REJEIÇÃO E DESCARTE DE AMOSTRA PELO LABORATÓRIO

Amostras que não atenderem aos critérios abaixo serão rejeitadas:

- | | |
|--|--|
| ✗ Tubo inadequado (tubo diferente do especificado) | ✗ Formulário incompleto |
| ✗ Presença de gel separador | ✗ Ausência de assinatura e/ou carimbo |
| ✗ Volume insuficiente | ✗ Temperatura inadequada |
| ✗ Amostras coaguladas e hemolizadas | ✗ Prazo superior a 72 horas entre coleta e envio |
| ✗ Amostras centrifugadas | |

Amostras recebidas fora dos critérios de coleta, armazenamento, transporte ou documentação estabelecidos nesta nota técnica também serão rejeitadas.

12

PRAZOS



RECOLHIMENTO DAS AMOSTRAS PELO LABORATÓRIO EXECUTOR

Até 3 dias úteis após a solicitação de retirada.



TRANSPORTE DAS AMOSTRAS ATÉ O LABORATÓRIO EXECUTOR

Até 3 dias corridos após a retirada das amostras no ponto de recolhimento.



ATENÇÃO!

O TEMPO ENTRE A COLETA DA AMOSTRA E O ENVIO AO LABORATÓRIO EXECUTOR PELO PONTO DE RECOLHIMENTO **NÃO DEVE ULTRAPASSAR 72 HORAS.**

TEMPO DE LIBERAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME

EXAME	PRAZO
Genotipagem convencional (Protease e Transcriptase Reversa)	Até 15 dias corridos
Integrase	Até 15 dias corridos
Genotipismo (Alça V3 GP120 – Maraviroque)	Até 25 dias corridos

ACOMPANHAMENTO DO EXAME

Todo o processo de execução do exame pode ser acompanhado pelo profissional solicitante por meio do Sistema LAUDO.



Acesse aqui ao Sistema Laudo

[Clique aqui](#)

O resultado também será disponibilizado no mesmo sistema.

EM CASO DE DÚVIDAS, QUEM CONTATAR?



Dúvidas sobre fluxos de solicitação, recolhimento e critérios para realização do exame:
Equipe de Diagnóstico/DATHI/SVSA/MS
diagnostico@aims.gov.br



Dúvidas sobre solicitação, critérios para realização do exame, condutas clínicas, esquemas de tratamento:
Núcleo de Cuidado e Qualidade de Vida/CGHA/DATHI/SVSA/MS
tratamento@aims.gov.br



Dúvidas sobre fluxos, agendamento de recolhimento de amostras e envio de material de coleta:
Empresa Germsure